

INFORME DE EVALUACIÓN INTERDISCIPLINARIO

I.- Antecedentes Personales.

Nombre : Máximo Palleres
R.U.T. : 27.638.468-6
Fecha de Nacimiento / edad : 13/10/2021 - 4 años
Nivel escolar : Prekinder
Establecimiento escolar :
Fecha evaluación : Desde el 15 de junio

II.- Motivo de consulta

Se realiza derivación desde Neurología por sospecha de TDA.

III.- Anamnesis.

Antecedentes se encuentran en formato de Anamnesis como anexo al documento.

IV.- Instrumentos de evaluación

- Observación clínica
- Entrevista a padres
- Cuestionario sensorial del hogar. SPM Sensory Processing Measure-preschool. Cheryl Ecker and L.Diane Parham.
- Evaluación estructurada de integración sensorial.
- Perfil Ocupacional inicial del niño (SCOPE) Registro Terapeuta Ocupacional/Reporte padres. The Modelo of Human Occupation Clearinghouse. Kielhofner.
- Edad de desarrollo para las actividades de la vida diaria. PORTAGE.
- Test de aprendizaje y desarrollo infantil TADI. Edwards M., Pardo M.
- Escala de juego preescolar de Susan Knox.
- Test de selectividad alimentaria en niños.

V. Análisis de resultados

I. Comportamiento observado.

Máximo se presenta con vestimenta y apariencia acorde a su edad e ingresa a la sala de forma independiente. Se adecua positivamente al espacio explorando la sala y todo el material para jugar. En cuanto a la consigna de las actividades propuestas, logra involucra al adulto en su juego, sin embargo, se observan desafíos para la transición de actividades y tolerancia a la frustración.

II. Valoración Cuantitativa.

Cuestionario sensorial del hogar. SPM Sensory Processing Measure-preschool. Cheryl Ecker and L.Diane Parham.

HOGAR

Comentarios:

ÁREAS	DENTRO DE LOS RANGOS ESPERADOS (40T - 59T)	ALGUNOS PROBLEMAS (60T - 69T)	DISFUNCIÓN (70T - 80T)
VISIÓN		64	
AUDICIÓN		60	
TACTO		62	
CONCIENCIA CORPORAL	57		
EQUILIBRIO Y MOVIMIENTO		62	
PLANIFICACIÓN E IDEAS	56		
PARTICIPACIÓN SOCIAL	54		



Evaluación estructurada de integración sensorial.

Sistema Vestibular <i>Vías evaluadas: vestibulo-espinal lateral y medial/ conexiones vestibulo-cerebelosas</i>	Sistema Propioceptivo	Sistema Táctil
Nistagmo post-rotatorio (NPR) (10 rotaciones en 20 segundos) Respuesta entregada: 6 1.- Extensión anti gravitatoria y estabilidad articular proximal: Inconsistente. 2.-Reacciones de protección: Logrado, apoya mano-muñeca. 3.-Reacciones de equilibrio: 3.1 Reactivas: Inconsistente. 3.2 Anticipatorias: Inconsistente. 4.-Coordinación ocular: 4.1.-Seguimiento ocular: Logrado en movimientos verticales y horizontales. 4.2.-Estabilidad ocular durante los movimientos de cabeza: Logrado. 5.- Coordinación motora bilateral y letalidad: 5.1.- Coordinación bil: Inconsistente. 5.2.- Lateralidad: Inconsistente. 6.- Feedforward: Inconsistente. 7.- Respuesta al movimiento: Frente a movimientos rotatorios expresa molestia, ante movimiento horizontales sin molestia.	1.-Alineación de articulaciones: Inconsistente, compensa con su cuerpo. Pierde control postural. 2.- Tono muscular: Dentro de rangos esperados. 3.-Control postural: Inconsistente con demanda. 4.- Planeamiento motor: Inconsistente. 5.-Manifestaciones corporales: Desregulaciones socioemocional: desafíos de frustración, resolución de problemas y participación en actividades de mayor demanda cognitiva.	1.-Registro: 1.1.- Registra sin ver: Necesita de anticipación, inconsistente. 1.2.-Se quita elementos sin ver: Logrado. 2.-Modulación: 2.1.-Copia 2D: Inconsistente. 2.2.-Copia 3D: Inconsistente. 2.3.-Copia con el cuerpo: -EE.SS: Logrado. -EE.II: Inconsistente. -Combinado: Inconsistente. 3.-Discriminación: 3.1.-Desafíos finos: Inconsistente. 3.1.-Dificultades oro-faciales: No pesquiasadas. 3.2.-Orden de su espacio: Inconsistente.

Perfil Ocupacional inicial del niño (SCOPE) Registro Terapeuta Ocupacional/Reporte padres. The Modelo of Human Occupation Clearinghouse. Kielhofnerf.

Área	Puntaje	Puntaje Total
Volición	4+4+4+1	13/16
Habitación	4+1+4+4	13/16
Habilidades de Comunicación e Interacción	2+2+4+4	12/16
Habilidades de Procesamiento	4+4+1+1	10/16
Habilidades Motoras	4+1+4+4	13/16
Ambiente	4+4+4+4+4	20/20
TOTAL		81/100



Edad de desarrollo para las actividades de la vida diaria. PORTAGE.

ACTIVIDAD	EDAD ACTUAL/APOYO
Alimentación	Acorde a edad cronológica, necesita supervisión sustancial.
Vestuario	Acorde a edad cronológica, necesita supervisión sustancial y apoyo para el abotonado/desabotonado.
Higiene	Acorde a edad cronológica, necesita supervisión sustancial.
Autocuidado-Responsabilidad	Acorde a edad cronológica, necesita supervisión sustancial.

Test de aprendizaje y desarrollo infantil TADI. Edwards M., Pardo M.

Dimensión	Puntaje bruto	Puntaje T	Categoría
Dimensión cognitiva	39	38	RIESGO
Dimensión motricidad	39	43	NORMAL
Dimensión lenguaje	46	50	NORMAL
Dimensión socioemocional	48	49	NORMAL
Escala total		38+43+50+49= 180:4=45	NORMAL CON REZAGO

Escala del juego preescolar de Susan Knox.

Dimensiones y factores	Edades en meses	Dimensiones y factores+	Edades en meses
1 Manejo del espacio	$48+48=96\%2= 48$ meses	3 Simulación/simbolismo	$48+48= 96\%2= 48$ meses
1.1 Motricidad gruesa	48	3.1 Imitación	48
1.2 Interés	48	3.2 Dramatización	48
2 Manejo de materiales	$50+50+60+48= 208\%4=52$ meses	4 Participación	$50+48+48+48= 194\%4= 49$ meses
2.1 Manipulación	50	4.1 Tipo	50
2.3 Construcción	50	4.2 Cooperación	48
2.4 Propósito	60	4.3 Humor	48
2.5 Atención	48	4.4 Lenguaje	48
Edad del desarrollo del juego	$48+48+52+49= 197\%4= 49$ meses/ 4 años 1 mes aproximadamente		

III. Valoración Cualitativa.

1.- Desarrollo Psicomotor:

1.1.- Motricidad Gruesa:

En primera instancia, Máximo cuenta con todos los **rangos de movimientos** pasivos y activos, donde al involucrarse en movimientos de mayor complejidad se observan desafíos para la prolijidad y fluidez de movimientos.

A nivel de **coordinación motriz**, se observa mayor dominio en la planificación de movimientos principalmente de EESS; al solicitar movimientos de EESS y EEII combinados se observa baja tolerancia a la frustración aumentando el nivel de alerta de Máximo.



A nivel de **actividades de retroalimentación (feedback)**, se observa una inconsistencia en su desempeño, sin embargo, al entregar modelamiento inicial y apoyo verbal logra permanecer en la actividad. En cuanto a nivel de **actividades de ensayo y error (feedforward)**, su participación es inconsistente, presentando desafíos para perseverar y permanecer en la actividad, queriendo cambiar la regla u objetivo.

A nivel de **planeamiento motor**, presenta desafíos para la proyección de movimientos solicitados por el adulto, necesitando modelamiento inicial y apoyo físico para mantenerse.

1.2.- Motricidad fina:

Máximo cuenta con todos los agarres esperados para su edad cronológica y en proceso de consolidación de pinzas, como la pinza lateral y pinza trípode.

A **nivel de control motor de lápiz**, Máximo se encuentra en proceso de consolidación, logrando realizar trazos rectos sin apoyo visual y trazos curvos con apoyo.

A **nivel de habilidades visomotoras**, necesita de un modelamiento para la copia de figuras y modelos visuales entregados, ya que al involucrarse tiende a utilizar mayor fuerza con lápices y elementos utilizados.

En relación a los **movimientos intramanuales**, logra la manipulación de más de un objeto a la vez en su mano, estirar plastilinas, formar figuras simples; mostrando una preferencia por realizar tareas propuestas con solo una mano. Al solicitar y ayudar a utilizar ambas manos Máximo logra participar por periodos cortos solicitando descansos y/o ayuda.

2.- Desarrollo Cognitivo:

Desde la evaluación TADI, el aspecto cognitivo se categoriza como un riesgo, evidenciando un rezago de acuerdo con su edad cronológica.

2.1.- Procesos básicos de atención/concentración:

Máximo logra mantener la atención en actividades de interés por un periodo de 10-15 minutos aproximadamente, lo cual cambia en actividades de mayor demanda cognitiva donde necesita movilizar su cuerpo y/o tener descansos para mantenerse focalizado.

2.2.- Procesos básicos de secuenciación de tarea:

Máximo logra reconocer y comprender secuencias a seguir con materiales terapéuticos y juegos, donde secuencia al menos 2 pasos sin apoyo. En actividades de mayor demanda cognitiva necesita que el material sea mediado para reconocer y no abandonar actividades.



2.3.- Procesos de discriminación y percepción visual:

Debido a componentes sensoriomotores Máximo presenta dificultades para logra la discriminación de elementos. Desde la percepción visual, Máximo presenta logra participar en actividades de figura-sombra simples, sin embargo, se observa desafíos para realizar dibujos/figuras que crucen la línea media y encontrar similitudes.

2.4.- Funciones ejecutivas:

2.4.1.- Flexibilidad cognitiva:

Máximo presenta algunos desafíos para lograr ceder frente a demandas solicitadas por adulto donde por medio de un apoyo verbal y visual, logra a los minutos comprender y ceder. Asimismo, se observaron dificultades para cambiar de actividad y adaptarse a cambios inesperados durante la sesión.

2.4.2.- Velocidad de procesamiento:

Máximo cuenta con un repertorio semántico acorde a su edad cronológica, permitiendo participar en actividades de categorías de adecuada manera.

2.4.3.- Control inhibitorio:

Desde el control inhibitorio, se observan desafíos para el respeto de turnos al hablar, seguir las reglas cuando se enfrenta a una actividad que no es de su interés y regular sus emociones ante la frustración.



3.- Procesamiento sensorial y conducta

Según lo pesquisado en la evaluación SPM y en la observación clínica de integración sensorial, se puede establecer los siguientes desafíos de modulación sensorial. A continuación, se describen:

Sistema sensorial	Tipo respuesta	Conductas proyectadas
Vestibular	Hiporrespuesta, desafíos en la modulación de estímulos.	-Busca movimientos oscilantes después de actividades con mayor demanda. -Busca moverse en su propio eje para la autorregulación. -Sentirse cansado en actividades con alta demanda. -No utiliza ambas manos.
Propioceptivo	Hiporrespuesta, desafíos en la modulación sensorial	-Falta de prolijidad en movimientos aislados y combinados. -Participa en actividades donde debe correr, arrastrar, saltar, chocar contra las cosas. -Desafíos en cierre de cadenas cinéticas -Busca la regulación con la movilidad de su cuerpo -Descoordinación motriz en movimientos de mayor complejidad.
Táctil	Hiperrespuesta, desafíos en modulación de estímulos.	-Desafíos en abotonado/desabotonado de vestuario. -Desafíos para la exploración de nuevos elementos, prefiere transitar en su gama conocidos. -Desafíos en la copia e imitación de patrones de movimientos en material concreto y de cuerpo. -Desafíos para la atención conjunta. -Evita jugar con espuma y ensuciarse las manos.
Gustativo	Hiperrespuesta, se debería seguir estudiando	-Es selectivo a ciertos sabores de comida al punto de rehusar a comer otros alimentos que se le ofrece -Rechaza texturas pegajosas, alimentos mezclados, olores fuertes y crujientes. -Expresa que le da asco las papillas

4.- Perfil ocupacional

4.1.- Habitación: Máximo logra reconocer y comprender las actividades de la vida diaria, al solicitar relatar el paso a paso de las actividades lo logra a mencionar, comenta que pide ayuda a sus padres para abotonarse prendas, interfiriendo lo manual en la independencia.

4.2.- Volicional: Máximo logra explorar su entorno donde con apoyo verbal logra buscar un material nuevo después de jugar con el que le gustó. Por otro lado, se observan desafíos para transitar de una actividad a otra, evidenciando rigidez y baja tolerancia a la frustración.



VI.- Síntesis / Diagnóstico

Desde el Área de Terapia Ocupacional se establece que Máximo presenta desafíos a nivel sensorial y emocional, lo cual interfiere en las ocupaciones significativas, tales como, INTERACCIÓN SOCIAL, JUEGO, AVD, EDUCACIÓN. Por lo cual, se buscará la regulación de modulación de los estímulos sensoriales y entrenamiento de habilidades acordes a su edad cronológica

Considerando los elementos aportados por la familia, la observación clínica y los instrumentos aplicados, es posible señalar que Máximo presenta un perfil acorde al Trastorno del Espectro Autista, donde se evidencia inflexibilidad cognitiva, desafíos para la transición de actividad con previa anticipación, bajo contacto visual y aspectos sensoriales que interfieren en su participación funcional.

VII.- Sugerencias / Derivaciones

A la familia:

- Se sugiere realizar evaluación ADOS y ADIR, con el fin de descartar o confirmar posible TEA.
- Se sugiere ingresar a intervención de Terapia Ocupacional con el fin de potenciar la tolerancia a la frustración, conducta adaptativa y aspectos sensoriales.
- Se sugiere potenciar la autonomía de Máximo en el hogar mediante el modelado de actividades donde presente más dificultades.
-

Es todo cuanto podemos informar.



Nicole Calderón
Terapeuta Ocupacional Infanto-juvenil
Reg. SIS: 871683
GRUPO PSICOEDUKA



Valeska Ananías Gómez
Directora Clínica
GRUPO PSICOEDUKA

Santiago. Julio 2026

